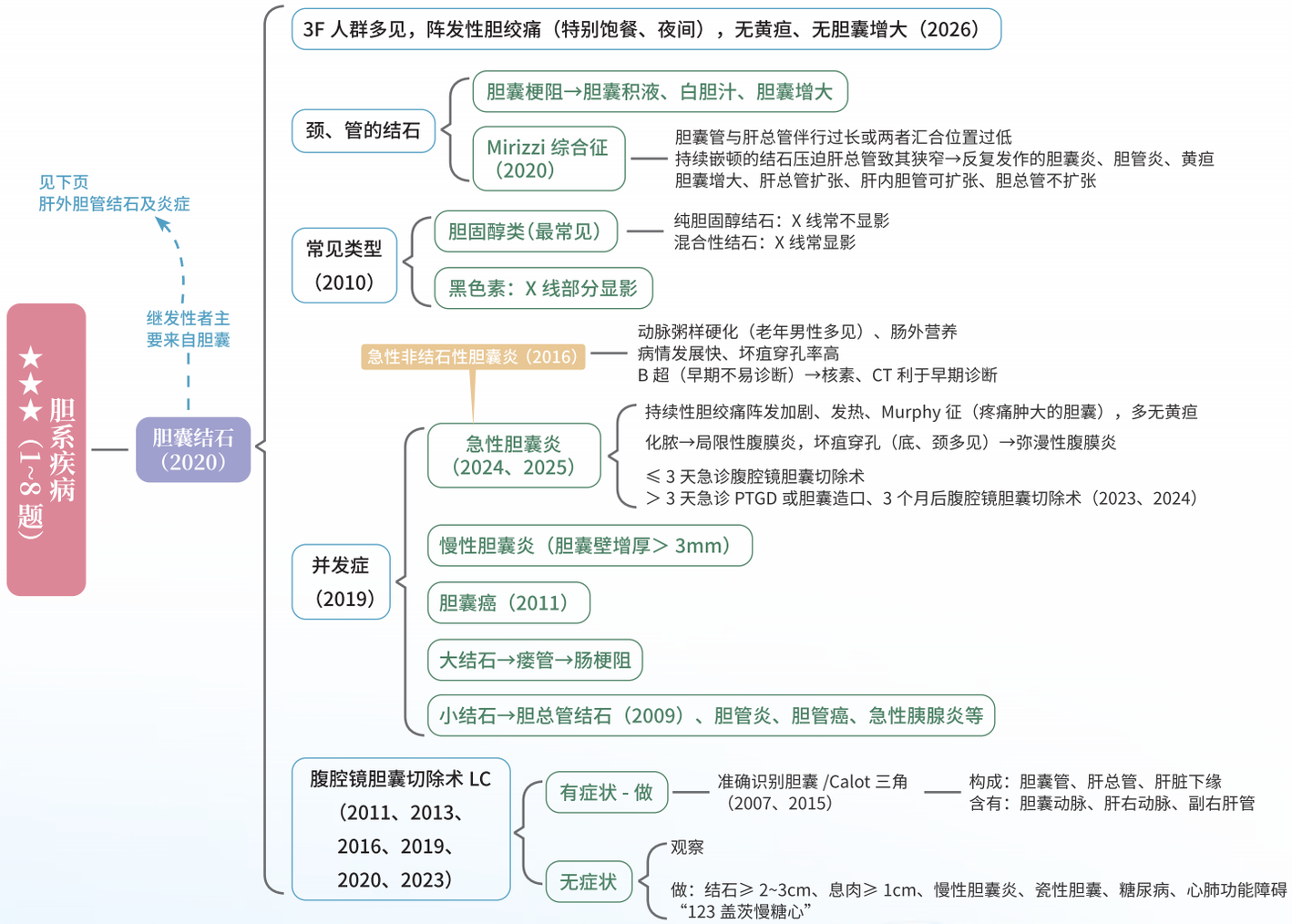

★★★胆系疾病（1~8题）
胆囊结石（2020）
见下页
肝外胆管结石及炎症
继发性者主要来自胆囊
3F 人群多见，阵发性胆绞痛（特别饱餐、夜间），无黄疸、无胆囊增大（2026）
颈、管的结石
胆囊梗阻→胆囊积液、白胆汁、胆囊增大
Mirizzi 综合征（2020）
胆囊管与肝总管伴行过长或两者汇合位置过低
持续嵌顿的结石压迫肝总管致其狭窄→反复发作的胆囊炎、胆管炎、黄疸
胆囊增大、肝总管扩张、肝内胆管可扩张、胆总管不扩张
常见类型（2010）
胆固醇类（最常见）
纯胆固醇结石：X 线常不显影
混合性结石：X 线常显影
黑色素：X 线部分显影
急性非结石性胆囊炎（2016）
动脉粥样硬化（老年男性多见）、肠外营养
病情发展快、坏疽穿孔率高
B 超（早期不易诊断）→核素、CT 利于早期诊断
并发症（2019）
急性胆囊炎（2024、2025）
持续性胆绞痛阵发加剧、发热、Murphy 征（疼痛肿大的胆囊），多无黄疸
化脓→局限性腹膜炎，坏疽穿孔（底、颈多见）→弥漫性腹膜炎
≤ 3 天急诊腹腔镜胆囊切除术
＞ 3 天急诊 PTGD 或胆囊造口、3 个月后腹腔镜胆囊切除术（2023、2024）
慢性胆囊炎（胆囊壁增厚＞ 3mm）
胆囊癌（2011）
大结石→瘘管→肠梗阻
小结石→胆总管结石（2009）、胆管炎、胆管癌、急性胰腺炎等
腹腔镜胆囊切除术 LC（2011、2013、2016、2019、2020、2023）
有症状 - 做
准确识别胆囊 /Calot 三角（2007、2015）
构成：胆囊管、肝总管、肝脏下缘
含有：胆囊动脉、肝右动脉、副右肝管
无症状
观察
做：结石≥ 2~3cm、息肉≥ 1cm、慢性胆囊炎、瓷性胆囊、糖尿病、心肺功能障碍
“123 盖茨慢糖心”